

Prolapso de órganos pélvicos

Información para el paciente · Cuando los órganos pélvicos descienden y causan un bulto o presión

WARWIKI

El prolapso de órganos pélvicos ocurre cuando el soporte alrededor de los órganos pélvicos — la vejiga, el útero o el recto — se debilita, y uno o más de ellos presionan hacia adentro o hacia afuera de la vagina. Esto causa un **bulto o una sensación de presión**. Es muy común, **no es peligroso ni es cáncer**, y hay buenas opciones que van desde ejercicios hasta un dispositivo de soporte o cirugía.

Acerca de esta afección

El prolapso recibe su nombre según la pared que desciende:

- **Pared anterior** (vejiga) — un cistocele
- **Pared posterior** (recto) — un rectocele
- **Parte superior** (útero, o la parte superior de la vagina después de una histerectomía)

Síntomas comunes:

- Un **bulto o protuberancia** que puede ver o sentir en la abertura vaginal
- **Presión o pesadez** en la pelvis, a menudo peor al final del día o al levantar cosas
- Dificultad para vaciar por completo la vejiga o el intestino; a veces hay que presionar el bulto para poder evacuar ("entablillado")

Qué la causa

Cualquier cosa que fuerce o debilite el soporte pélvico: **el embarazo y el parto**, la menopausia y el envejecimiento, el esfuerzo crónico (estreñimiento o tos), levantar objetos pesados, cirugía pélvica previa, el peso extra y la tendencia familiar.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Prolapso

Cuando un órgano pélvico desciende de su posición normal.

Cistocele

Abultamiento de la vejiga hacia la pared vaginal anterior.

Rectocele

Abultamiento del recto hacia la pared vaginal posterior.

Cúpula vaginal

La parte superior de la vagina, que puede descender después de una histerectomía.

Pesario

Un soporte removible que se coloca en la vagina para sostener los órganos en su lugar.

Entablillado

Presionar el bulto para ayudar a vaciar la vejiga o el intestino.

Suelo pélvico

Los músculos que sostienen los órganos pélvicos.

POP-Q

El examen que se usa para medir cuánto se extiende el prolapso.

¿TENGO QUE TRATARLO? Solo si le molesta. El prolapso no es peligroso, así que si los síntomas son leves puede simplemente vigilarlo. Cuando afecta su comodidad o su vida diaria, usted elige entre varias opciones eficaces — no hay una sola respuesta “correcta”, y puede cambiar de opinión con el tiempo.

Cómo se diagnostica

- Un **examen pélvico**, a menudo de pie o haciendo fuerza hacia abajo, para ver qué paredes descienden y hasta dónde
- Una revisión de los síntomas de la vejiga y el intestino
- A veces **pruebas de la función de la vejiga** si además tiene escapes de orina

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 **Vigilancia activa** si no le molesta, además de prevención (tratar el estreñimiento, evitar levantar objetos pesados, controlar el peso).
- 2 **Ejercicios del suelo pélvico / fisioterapia** para el prolapso leve.
- 3 Un **pesario** — un soporte removible que alivia el bulto sin cirugía.
- 4 **Cirugía** — una reparación para restaurar el soporte, un cierre vaginal (colpocleisis) o una suspensión. Cada una tiene su propia hoja.

Vivir con prolapso

- Mantenga las heces blandas y **evite hacer esfuerzo**; no levante más peso del que su equipo le aconseje.
- Haga ejercicios del suelo pélvico; controle la tos y el peso.
- Un pesario puede ser una solución a largo plazo, no solo una medida temporal.

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede orinar** ni evacuar el intestino
- El bulto se vuelve **doloroso, sangra o está en carne viva o ulcerado**
- Fiebre, o no puede volver a meter el bulto hacia adentro

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El prolapso es un descenso común y no peligroso de los órganos pélvicos que causa un bulto o presión.
2. Trátelo solo si le molesta — las opciones van desde la vigilancia activa y los ejercicios hasta un pesario o la cirugía.
3. Evite hacer esfuerzo y levantar objetos pesados. Busque atención si no puede vaciar la vejiga o el intestino, o si el bulto se vuelve doloroso o queda en carne viva.